

# Заболеваемость и смертность от злокачественных заболеваний у женщин в г. Баку

Ватанха С. С.

Национальный центр онкологии Минздрава Азербайджанской Республики,  
Азербайджанская Республика, г.Баку

В структуре смертности населения земного шара от всех нозологических форм заболеваний смертность от злокачественных новообразований занимает 3-е место, а в ряде стран с высоко-развитой индустрией конкурирует с показателями смертности сердечно-сосудистыми заболеваниями [2,10].

Рак молочной железы во многих частях земного шара является одной из наиболее часто встречающихся злокачественных опухолей у женщин. Кроме того, это одна из лидирующих причин смерти женщин от рака [1].

Примечательно, что с 1999 г. онкологические заболевания обогнали сердечно-сосудистые в качестве лидирующей причины смертности среди лиц моложе 85 лет. Среди лиц старше 85 лет наблюдается обратная ситуация [7].

В мире в 2002 году по различным оценкам произошло 11 миллионов новых случаев заболевания злокачественными новообразованиями и 7 миллионов смертей в результате их развития. И, в то же время, приблизительно 25 миллионов человек живут, продолжая болеть раком [8].

Различия в заболеваемости, смертности и распространенности злокачественных новообразований в отдельных регионах мира связаны с генетическими различиями и старением населения, однако, также играют роль и корригируемые факторы риска, такие, как курение, инфекционные заболевания, питание (недостаточное употребление фруктов и овощей) и физическая деятельность. Другие корригируемые факторы риска включают в себя избыточный вес/ожирение, загрязнение воздуха в городах, задымление жилых помещений из-за использования огня в хозяйстве, небезопасный секс и нестерильные инструменты в медицинских учреждениях [6].

Судя по всему, не менее одной трети смертей от онкологических заболеваний в мире можно предотвратить. Известные к настоящему времени этиологические факторы развития злокачественных новообразований подразделяют на химические вещества и вещества естественного происхождения, лекарственные препараты и гормоны, возбудители инфекций и различные их ассоциации [9].

При раке молочной железы лишь 5-10% случаев обусловлены наследственными факторами. Среди случаев наследственного и семейного рака молочной железы приблизительно за половину из них ответственны мутации BRCA1 и/или BRCA2 [5].

В настоящее время сложилось представление о том, что причиной заболевания злокачественными новообразованиями является действие на организм целой группы как эндогенных, так и экзогенных факторов [4].

Рак молочной железы - многофакторное заболевание, его развитие связано с изменениями генома клетки под воздействием внешних причин и гормонов [3].

Город Баку - столица Азербайджанской Республики с населением 2,0785 тыс. людей. При

*Morbidity And Mortality Of Malignant Diseases Among Women In Baku City*

*Vatankhah S.*

1. Breast cancer has a leading position among all malignancies, which has extensive index of 34.4% and the intensity index of 42.9 per 100 000.

2. The overall mortality rate is relatively high in patients with breast cancer (22.5 per 100 000) and is lowest in patients with cancer of the uterus (3.2 per 100 000).

3. Fatality rates are relatively low and vary in range of 15.3% (breast cancer) to 21.9% (cervical cancer)

сравнительно небольшой площади 2,13 тыс. км<sup>2</sup> плотность населения довольно высока и превышает общереспубликанский показатель более 9 раз (982 против 105).

В административно-территориальном аспекте г. Баку состоит из 11 административных районов. Более 50% населения (50,5%) составляют лица женского пола.

Нами была изучена заболеваемость и смертность ведущими злокачественными заболеваниями у женщин во всех 11 административных районах как в отдельности, так и в целом по г. Баку.

В структуре заболеваемости злокачественными заболеваниями основные нозологические формы составили: рак молочной железы, рак тела матки, рак шейки матки, яичники. Показатели экстенсивности составили 34,4%, 7,3%, 5,4% и 7,3%, соответственно.

Рак молочной железы - основная нозологическая форма заболеваемости злокачественными новообразованиями у женщин г. Баку, интенсивный показатель которого составляет 42,9 на 100 тыс. населения. Следует отметить, что наиболее высокие уровни заболеваемости отмечаются в Ясамальском и Сабунчинском районах (55,4 и 51,6 на 100 тыс., соответственно), а наименее низкие - в Наримановском и Насиминском

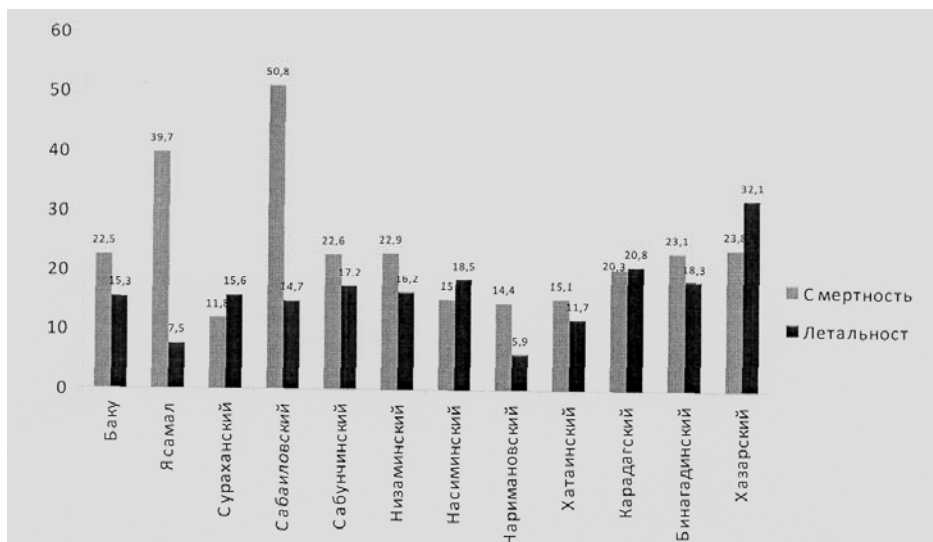


Рис. 1. Показатели смертности и летальности рака молочной железы г. Баку

Таблица 1- Основные эпидемиологические показатели заболеваемости злокачественными новообразованиями рака шейки матки в различных административных районах города Баку

| Районы города | Экстенсивный % | Интенсивный на 100 тыс. | Смертность на 100 тыс. | Летальность % | 5 - летняя выживаемость % | Стадии % |      |      |
|---------------|----------------|-------------------------|------------------------|---------------|---------------------------|----------|------|------|
|               |                |                         |                        |               |                           | I - II   | III  | IV   |
| Ясамальский   | 6,5            | 9,8                     | 8,2                    | 16,6          | 52,9                      | 66,6     | 25,0 | 8,4  |
| Сураханский   | 8,9            | 11,8                    | 5,9                    | 16,6          | 42,8                      | 83,4     | 8,3  | 8,3  |
| Сабаилловский | 7,3            | 14,8                    | 12,7                   | 28,6          | 51,4                      | 42,8     | 28,6 | 28,6 |
| Сабунчинский  | 10,3           | 14,2                    | 4,5                    | 18,8          | 35,9                      | 62,5     | 25,0 | 12,5 |
| Низаминский   | 7,4            | 9,8                     | 4,4                    | 11,1          | 41,0                      | 33,3     | 55,5 | 11,2 |
| Насиминский   | 8,1            | 5,6                     | 0,9                    | 16,6          | 39,4                      | 50,0     | 33,3 | 16,7 |
| Наримановский | 2,7            | 2,4                     | 3,6                    | 50,0          | 33,3                      | 90,0     | 5,0  | 5,0  |
| Хатаинский    | 5,0            | 6,3                     | 5,5                    | 37,5          | 59,4                      | 62,5     | 25,0 | 12,5 |
| Карадагский   | 6,0            | 5,5                     | 3,6                    | 33,3          | 17,6                      | 66,6     | 16,7 | 16,7 |
| Бинагадинский | 5,8            | 8,3                     | 4,9                    | 30,0          | 44,8                      | 80,0     | 10,0 | 10,0 |
| Хазарский     | 12,1           | 13,1                    | 7,2                    | 36,4          | 25,0                      | 45,5     | 36,4 | 18,1 |

(20,4 и 24,4 на 100 тыс., соответственно).

Как видно из рис. 1, наиболее высокие показатели общего коэффициента смертности отмечаются в Сабаилловском и Ясамальском районах (50,8 и 39,7 на 100 тыс., соответственно), превышающие общегородской показатель 2205 на 100 тыс.

Показатель летальности высок в Хазарском районе (32,1%), превышающий общегородской показатель более, чем в 2 раза (15,3%).

Величина 5-летней выживаемости в целом по г. Баку достаточно высока и составляет

44,6%. Наиболее высокий уровень отмечен в Наримановском районе - 59,4%, а наиболее низкий - в Бинагадинском (30,0%).

Данное положение нашло свое отражение при анализе данных заболеваемости раком молочной железы в зависимости от стадии заболеваемости. Более 50% больных составили лица с I—II клинической стадией. Общереспубликанский показатель составил 67,8% (I-II стадии), 7,0 - III стадия и 14,5 - IV стадия.

Рак шейки матки занимает 2 позицию в структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями у лиц женского пола в г. Баку (табл. 1)

Как видно из таблицы 1, при величине общегородского показателя заболеваемости 91 на 100 тыс. высокие уровни отмечены в Сабаилловском и Сабунчинском районах, величина интенсивного показателя которых составила 14,8 и 14,2 на 100 тыс., соответственно. Аналогичная картина была отмечена при расчете показателя смертности рака шейки матки. Так, при величине общегородского показателя 5,3 на 100 тыс. в Сабаилловском районе аналогичный показатель составил 12,7 на 100 тыс. Наименьшая величина была отмечена в Низаминском районе (0,9 на 100 тыс.).

Показатель летальности относительно невелик и составляет, в целом, по городу Баку 21,9%. Однако, следует отметить невысокий уровень показателя летальности в Наримановском и Хатаинском районах (50,0% и 37,5%, соответственно).

Величина 5-летней выживаемости,

как и в случае заболеваемости раком молочной железы, составила 43,5%.

При этом, в 2-х административных районах города (Хатаинский и Ясамальский) данный показатель составил 59,4% и 52,9%, соответственно.

Наиболее часто встречаемой клинической стадией заболеваемости раком шейки матки составили больные 1-й стадией (61,4%). У 33,3% больных раком шейки матки I—II клинические стадии были отмечены в Низаминском районе.

Рак яичника занимает третью позицию среди злокачественных новообразований у женщин в г. Баку. Показатели заболеваемости по различным административным районам г. Баку варьируют в диапазоне 1,2-14,8 на 100 тыс. при величине общегородского - 9,0 (рис.2).

Экстенсивный показатель также достаточно вариабелен и колеблется в диапазоне от 1,1% (Хазарский район) до 12,0% (Карадагский район).

Относительно высокие показатели общего коэффициента смертности от-

мечены в Сабаилловском и Сураханском районах (8,5 и 7,8 на 100 тыс., соответственно), превышающие общегородской показатель в 2 раза (4,4 на 100 тыс.).

Коэффициент летальности относительно низкий и составляет 18,8%; относительно высок в Хатаинском и Бинагадинском районах (35,7% и 30,8%, соответственно), а наиболее низкий - в Ясамальском, Сабунчинском и Хазарском районах (100%, соответственно). Показатель 5-летней выживаемости низкий и составляет 38,2%. Диапазон колебаний данного показателя по отдельным районам г. Баку высок и имеет амплитуду колебаний от 8,0% (Бинагадинский район) до 60,0% (Хазарский район).

Данное положение нашло отражение и при анализе клинических стадий заболеваемости. Так, среди первичных больных раком яичника I—II клиническая стадия была отмечена у 53,1% больных.

Наиболее неблагоприятная ситуация отмечается в Хатаинском районе, где количество больных с I—II клиническими стадиями составляют всего 7,1%, а наиболее благоприятная - в Хазарском районе (90,0%) больных I—II стадией).

Рак тела матки занимает 4 позицию в структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями у женщин в г. Баку. Показатель экстенсивности составляет 5,4%. Следует отметить достаточно высокий показатель заболеваемости данной нозологией в ряде районов города (Сабаилловский,

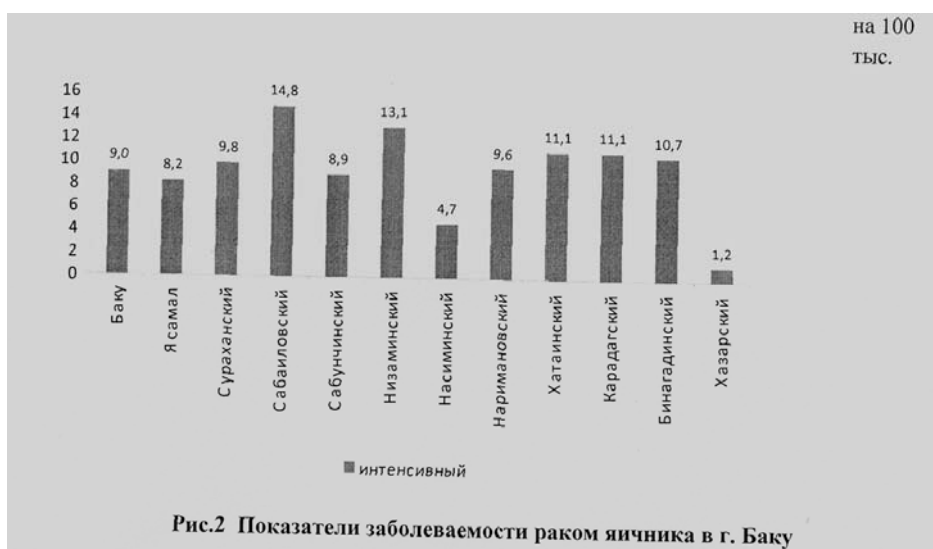
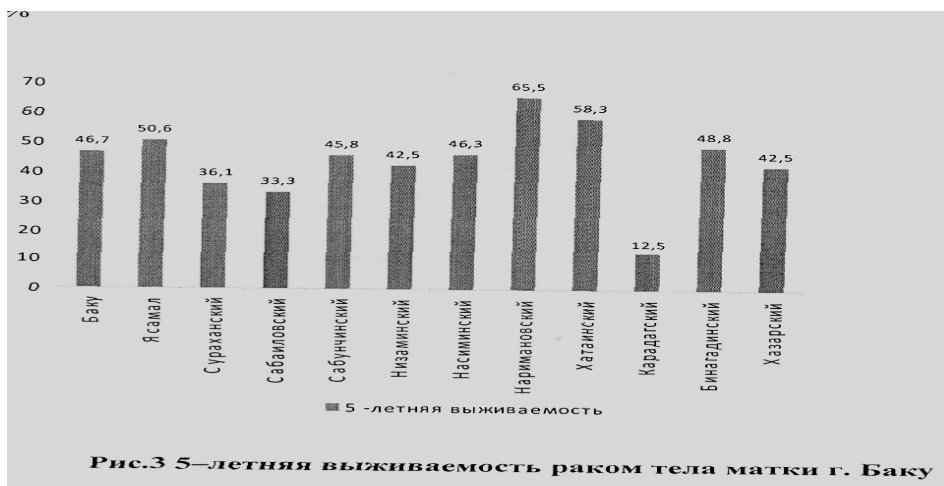


Рис.2 Показатели заболеваемости раком яичника в г. Баку



ные с III—IV клиническими стадиями (50,0% и 57,1%, соответственно).

## Выводы

1. В структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями рак молочной железы занимает ведущую позицию, экстенсивный показатель которого составляет 34,4%, а показатель интенсивности - 42,9 на 100 тыс.

2. Общий коэффициент смертности относительно высок у больных раком молочной железы (22,5 на 100 тыс.), а наиболее низок - у больных раком тела матки (3,2 на 100 тыс.).

3. Показатели летальности относительно невысоки и варьируют в диапазоне от 15,3% (рак молочной железы) до 21,9% (рак шейки матки).

Бинагадинский районы - 12,7 и 10,7 на 100 тыс. соответственно) при величине общегородского показателя 6,8.

Общий коэффициент смертности относительно невысокий и составляет, в целом, по городу 3,2 на 100 тыс.

Отмечается некоторое превышение общегородского показателя в Наримановском и Сабаилловском районах (4,8 и 4,2 на 100 тыс., соответственно).

Показатель летальности относительно невысок и составляет 19,7%. Однако, в ряде административных районов отмечаются высокие уровни данного показателя, превышающие общегородской в несколько раз (Карадагский - 60,0%, Хазарский и Насиминский - 50,0%, соответственно). Величины 5-летней выживаемости злокачественных новообразований тела матки представлены на рис 3.

Как видно, наиболее высоких показателя отмечены в Наримановском и Хатаинском районах (65,5% и 58,3%, соответственно), а наиболее низкие - в Карадагском районе (12,5%) при величине общегородского показателя 46,7%.

Наиболее часто регистрируемой клинической стадией заболеваемости для данной нозологии является I—II стадия (66,2%). Высокий уровень отмечен в Ясамальском и Низаминском районах (90,0% и 87,5%, соответственно).

Следует отметить, что в 2 административных районах г. Баку (Карадагский и Хатаинский районы) преобладают боль-

## Список использованной литературы

1. Брюзгин В.В. Опухоли женской репродуктивной системы. - 2007- №9. С. 6-104.
2. Ганцев Ш.Х. Онкология.-М.: МИА, 2004.- С.23-24.
3. Давыдов М.И., Аксель Е.М. Заболеваемость злокачественными новообразованиями // Вестн. РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН.- 2007ю- Т.18.- С.52-89.
4. Мамедов М.К. - Экоэнергетика, 2004.- №1.- С. 15-20.
5. Bennet I., Gattas M. The management of familial breast cancer // Breast.- 2000.- Vol..9.- P.247-263.
6. Ezzati M., Henley S., Lopez A. et al. Role of smoking in global and regional cancer epi demiology: Current patterns and data needs //Int. J. Cancer.- 2005.- Vol..I 16.- P.963-971.
7. Jemal A., Siegel R., Ward E. et al. Cancer statistics, 2006 // CA Cancer J Clin.- 2006.- Vol.56.- P.106-130.
8. Khatcheressian J., Wolff A., Smith T. et al. American Society of Clinical Oncology 2006 update of the breast cancer follow-up and management guidelines in the adjuvant setting // J. Clin. Oncol. - 2006.- Vol.24.- P.5091-5097.
9. Neugent A. Cancer epidemiology and prevention // Sci Am.- 2004.- Vol. 12.- P.2-11.
10. Yancik R. Population aging and cancer: a cross-national concern // Cancer J.- 2005.-Vol.II.- P.437-441/